



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN SISTEM PELAPORAN DAN
ANALISIS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor

Tentang
Panduan Sistem Pelaporan Dan Analisis Insiden Keselamatan Pasien

Disusun oleh :
Penanggung Jawab Bab Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien

(dr. Ari Putriani, Sp. PK)

Disetujui oleh :
Authorized Person

(Dr. dr. Aslichah, M. Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini. M.Kes)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Sistem Pelaporan dan Analisis Insiden Keselamatan Pasien dapat disusun dengan baik.

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh staf rumah sakit dalam melaksanakan pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien secara sistematis dan terstandar guna mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien.

Kami berharap panduan ini dapat digunakan dengan baik dan menjadi salah satu sarana dalam membangun budaya keselamatan di rumah sakit. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan panduan ini di masa mendatang.

PLT Direktur Rumah Sakit Prima



dr. Resti Lestantini, M.Kes



TIM PENYUSUN

1. dr. Resti Lestantini, M.Kes
2. Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb
3. Dwi Novianti, Amd.AK., S.Kes
4. drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
5. dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M
6. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An.TI
7. dr. Aida Musyarofah, Sp. OG
8. Fariz Tiarawan Faril Cahyono, S.Kep.Ns
9. Faisal Aminudin Ilham, S.KM

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Panduan.....	6
a. Tujuan Umum	6
b. Tujuan Khusus	6
BAB II DEFINISI OPERASIONAL	7
2.1 Definisi Keselamatan Pasien	7
2.2 Jenis Insiden Keselamatan Pasien	7
BAB III PELAPORAN DAN GRADING KESELAMATAN PASIEN	9
3.1 Insiden Keselamatan Pasien	9
3.2 Jenis Insiden di Rumah Sakit	10
3.3 Alur Pelaporan Insiden	11
3.4 Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).....	14
3.5 Petunjuk Pengisian Laporan IKP Eksternal	14
3.6 Manajemen Data SIMRS Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	22
BAB IV PENANGANAN KEJADIAN SENTINEL YANG BERDAMPAK LUAS/NASIONAL ..	27
4.1 Definisi Kejadian Sentinel Yang Berdampak Luas/Nasional	27
4.2 Pelaporan Kejadian Sentinel Yang Berdampak Luas/Nasional	27
4.3 Tindak Lanjut Kejadian Sentinel Yang Berdampak Luas/Nasional	27
BAB V PENUTUP	29

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR

TENTANG

PANDUAN PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit, diperlukan sistem pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien yang komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan sebagai upaya pembelajaran serta pencegahan terulangnya insiden yang dapat merugikan pasien;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 633.5/I-PDM/DIR/VII/2025 tentang Pedoman Sasaran Keselamatan Pasien perlu adanya Panduan Sistem Pelaporan Dan Analisis Insiden Keselamatan Pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Panduan Sistem Pelaporan Dan Analisis Insiden Keselamatan Pasien.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan No.HK.02.02/D/43961/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menerapkan : Kesatu : **PANDUAN SISTEM PELAPORAN DAN ANALISIS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

- (1) Keselamatan/*Safety* adalah bebas dari bahaya atau risiko (*hazard*)
- (2) *Hazard*/bahaya adalah suatu “Keadaan, Perubahan atau Tindakan” yang dapat meningkatkan risiko pada pasien.

- (3) Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
- (4) Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien.
- (5) Rumah Sakit menetapkan Regulasi tentang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal (Komite Nasional Keselamatan Pasien Kemenkes RI).
- (6) Rumah Sakit memiliki bukti tentang laporan insiden keselamatan pasien paling lambat 2x24 jam.
- (7) Rumah Sakit memiliki bukti pelaksanaan tentang integrasi laporan dan analisis data laporan insiden dengan Komite Mutu dan perbaikannya.
- (8) Rumah Sakit memiliki bukti tentang laporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien setiap 6 bulan kepada representasi pemilik.
- (9) Rumah Sakit memiliki bukti laporan kejadian sentinel kepada representasi pemilik paling lambat 2x24 jam.
- (10) Rumah Sakit memiliki bukti laporan kejadian sentinel kepada KNKP paling lambat 2x24 jam.
- (11) Rumah Sakit memiliki bukti laporan insiden keselamatan pasien khususnya sentinel kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien paling lambat 2x24 jam.

BAB II

INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 1

Insiden keselamatan pasien (IKP) di rumah sakit meliputi:

- a. Kondisi Potensial Cedera Signifikan (KPCS);
- b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);
- c. Kejadian Tidak Cedera (KTC); dan
- d. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).

Bagian Kesatu

Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Tidak Cedera (KTC)

Pasal 2

- (1) Rumah sakit menetapkan definisi, jenis yang dilaporkan dan sistem pelaporan dari KNC dan KTC.
- (2) Kejadian Nyaris Cedera (KNC) / Near Miss merupakan suatu Insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien
- (3) Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera, dapat terjadi karena "keberuntungan" (misal; pasien terima suatu oba kontra indikasi tetapi

- tidak timbul reaksi obat), atau "peringanan" (suatu obat dengan reaksi alergi diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan antidotumnya).
- (4) Ada analisis data KNC dan KTC

Bagian Kedua Kejadian Tidak Diharapkan

Pasal 3

- (1) Rumah sakit melakukan analisis data KTD dan mengambil langkah tindak lanjut.
- (2) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) / Adverse Event merupakan Suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan ("commission") atau karena tidak bertindak ("omission"), bukan karena "underlying disease" atau kondisi pasien.
- (3) Analisis dilakukan untuk semua hal berikut ini:
 - a. Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi, jika sesuai untuk rumah sakit
 - b. semua kejadian serius akibat efek samping obat, jika sesuai dan sebagaimana yang didefinisikan oleh rumah sakit
 - c. semua kesalahan pengobatan yang signifikan jika sesuai dan
 - d. semua perbedaan besar antara diagnosis praoperasi dan diagnosis pascaoperasi
 - e. efek samping atau pola efek samping selama sedas moderat atau mendalam dan pemakaian anestesi
 - f. kejadian-kejadian lain misalnya,
 - i. infeksi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau wabah penyakit menular sebagaimana yang didefinisikan oleh rumah sakit
 - ii. pasien jiwa yang melarikan diri dari ruang perawatan keluar lingkungan RS yang tidak meninggal/ tidak cedera serius. (Khusus untuk RS Jiwa dan RS Umum yang mempunyai ruang perawatan jiwa.

Bagian Ketiga Kejadian Sentinel

Pasal 4

- (1) Kejadian Sentinel (Sentinel Event) merupakan Suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti : operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata "sentinel" terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (misalnya Amputasi pada kaki yang salah, dan sebagainya) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit menetapkan definisi operasional kejadian sentinel yaitu:
 - a. Kematian yang tidak diduga, termasuk, dan tidak tidak terbatas hanya:
 - i. kematian yg tidak berhubungan dgn perjalanan penyakit pasien atau kondisi pasien (contoh, kematiandsetelah infeksi pasca operasi atau emboli paru paru)
 - ii. kematian bayi aterm
 - iii. bunuh diri
 - b. kehilangan permanen fungsi yang tidak terkait penyakit pasien atau kondisi pasien

- c. operasi salah tempat, salah prosedur, salah pasien
 - d. terjangkit penyakit kronik atau penyakit fatal akibat transfusi darah atau produk darah atau transplantasi organ atau jaringan
 - e. penculikan anak termasuk bayi atau anak termasuk bayi dikirim ke rumah bukan rumah orang tuanya
 - f. perkosaan, kejahatan di tempat kerja seperti penyerangan (berakibat kematian atau kehilangan fungsi
 - g. secara permanen) atau pembunuhan (yang disengaja) atas pasien, anggota staf, dokter, mahasiswa kedokteran, siswa latihan, pengunjung atau vendor / pihak ketiga ketika berada dalam lingkungan rumah sakit
- (3) Bukti pelaksanaan RCA/AAM tidak melewati 45 hari dari waktu terjadinya kejadian.
- (4) Bukti rencana tindak lanjut RCA/AAM yang telah dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan penanganan Insiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Selain penanganan Insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus melakukan penanganan kejadian sentinel.

BAB III

PENANGANAN KEJADIAN SENTINEL YANG BERDAMPAK LUAS/NASIONAL

Kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional meliputi kejadian sentinel yang memiliki potensi berdampak luas dan/atau kejadian sentinel yang melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lain.

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan sistem pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 03 Januari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR :
TENTANG PANDUAN SISTEM PELAPORAN
DAN ANALISIS INSIDEN KESELAMATAN
PASIEN

PEDOMAN KESELAMATAN PASIEN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, efektif, dan berorientasi pada pasien. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu adalah penerapan keselamatan pasien melalui identifikasi, pelaporan, analisis, dan tindak lanjut terhadap setiap insiden keselamatan pasien yang terjadi maupun yang berpotensi terjadi.

Insiden Keselamatan Pasien (IKP) merupakan setiap kejadian atau kondisi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden tersebut meliputi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi Potensial Cedera (KPC), dan Kejadian Sentinel. Apabila tidak dikelola dengan baik, insiden keselamatan pasien dapat berdampak pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, kepercayaan masyarakat, serta reputasi rumah sakit.

Pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan salah satu strategi penting dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan rumah sakit mengidentifikasi risiko, menemukan akar permasalahan, melakukan pembelajaran organisasi, serta menetapkan tindakan perbaikan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Oleh karena itu, budaya pelaporan yang bersifat terbuka, adil, dan tidak menyalahkan individu (no blame culture) perlu dikembangkan di seluruh unit pelayanan rumah sakit.

Di Indonesia, pelaksanaan keselamatan pasien dan pelaporan insiden keselamatan pasien diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta standar akreditasi rumah sakit yang mewajibkan rumah sakit memiliki sistem pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien yang terintegrasi dalam program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).

Untuk menjamin pelaksanaan pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien yang efektif, konsisten, dan terstandar, diperlukan Panduan Sistem Pelaporan dan Analisis Insiden Keselamatan Pasien sebagai acuan bagi seluruh staf dan unit kerja di rumah sakit. Panduan ini mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, analisis, pelaporan eksternal, tindak lanjut perbaikan, serta pembelajaran dari setiap insiden keselamatan pasien sebagai upaya mewujudkan budaya keselamatan dan peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

1.2 Tujuan Panduan

a. Tujuan Umum

Pedoman Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini disusun sebagai acuan bagi seluruh staf rumah sakit dalam melaksanakan pelaporan, investigasi, analisis, tindak lanjut, dan pembelajaran dari Insiden Keselamatan Pasien secara sistematis, terstandar, dan berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan budaya pelaporan insiden keselamatan pasien di seluruh unit rumah sakit.
2. Menyediakan mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien yang mudah, aman, dan tidak bersifat menyalahkan (*non-punitive*).
3. Memastikan setiap insiden keselamatan pasien dilaporkan, didokumentasikan, dan dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mengidentifikasi akar masalah dan faktor penyebab terjadinya insiden keselamatan pasien.
5. Menetapkan dan memantau pelaksanaan tindakan perbaikan untuk mencegah terulangnya insiden yang sama.
6. Mendukung proses pembelajaran organisasi melalui pemanfaatan data insiden keselamatan pasien sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan.
7. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi rumah sakit terkait pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien.

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL

2.1 Definisi Keselamatan Pasien

Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

2.2 Jenis Insiden Keselamatan Pasien

Insiden Keselamatan Pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden di Rumah Sakit meliputi:

- a. Kondisi Potensial Cedera Signifikan (KPCS): merupakan kondisi (selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri) yang berpotensi menyebabkan kejadian sentinel.
- b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC): merupakan insiden keselamatan pasien yang belum terpapar pada pasien
- c. Kejadian Tidak Cedera (KTC): merupakan insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien namun tidak menyebabkan cedera.
- d. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD): merupakan insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien.
- e. Sentinel: merupakan kejadian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien. Kejadian sentinel merupakan salah satu jenis insiden keselamatan pasien yang harus dilaporkan yang menyebabkan terjadinya hal-hal berikut ini:

- a) Kematian
- b) Cedera permanen: dampak yang dialami pasien yang bersifat ireversibel akibat insiden yang dialaminya misalnya kecacadan, kelumpuhan, kebutaan, tuli, dan lain-lain.
- c) Cedera berat yang bersifat sementara/reversible: cedera yang bersifat kritis dan dapat mengancam nyawa yang berlangsung dalam suatu kurun waktu tanpa terjadi cedera permanen/gejala sisa, namun kondisi tersebut mengharuskan pemindahan pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi/pengawasan pasien untuk jangka waktu yang lama, pemindahan pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi karena adanya kondisi yang mengancam nyawa, atau penambahan operasi besar, tindakan, atau tata laksana untuk menanggulangi kondisi tersebut.

Kejadian juga dapat digolongkan sebagai kejadian sentinel jika terjadi salah satu dari berikut:

- a) Bunuh diri oleh pasien yang sedang dirawat, ditatalaksana, menerima pelayanan di unit yang selalu memiliki staf sepanjang hari atau dalam waktu 72 jam setelah pemulangan pasien, termasuk dari Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit;
- b) Kematian bayi cukup bulan untuk diantisipasi;
- c) Bayi dipulangkan kepada orang tua yang salah;
- d) Penculikan pasien yang sedang menerima perawatan, tata laksana, dan pelayanan;
- e) Kaburnya pasien (atau pulang tanpa izin) dari unit perawatan yang selalu dijaga oleh staf sepanjang hari (termasuk UGD), yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat bagi pasien tersebut;

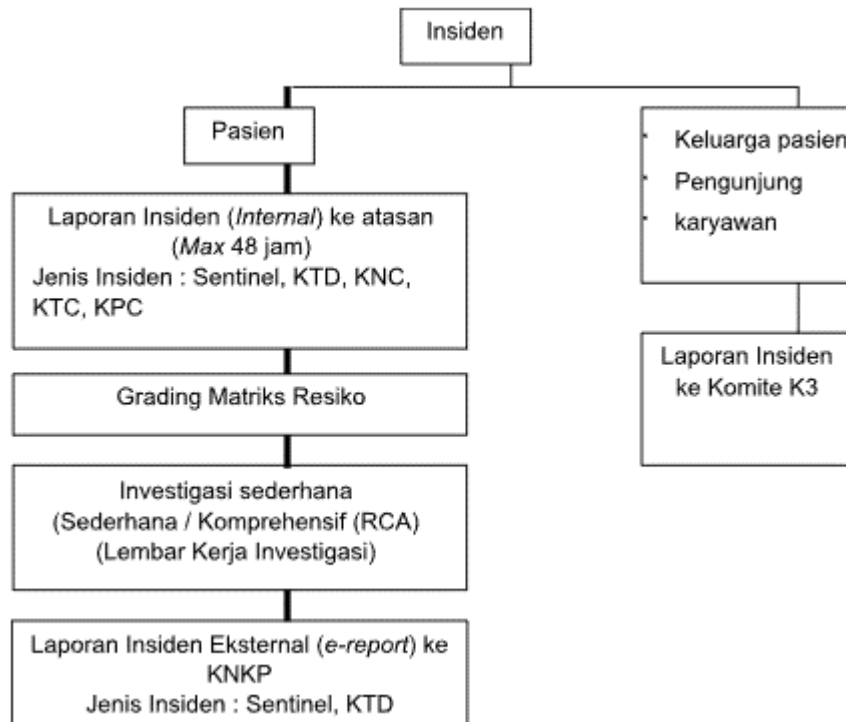
-
- f) Reaksi transfusi hemolitik yang melibatkan pemberian darah atau produk darah dengan inkompabilitas golongan darah mayor (ABO, Rh, kelompok darah lainnya);
 - g) Pemerkosaan, kekerasan (yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat) atau pembunuhan pasien yang sedang menerima perawatan, tata laksana, dan layana ketika berada dalam lingkungan rumah sakit;
 - h) Pemerkosaan, kekerasan (yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat) atau pembunuhan anggota staf, praktisi mandiri berizin, pengunjung, atau vendor ketika berada dalam lingkungan rumah sakit;
 - i) Tindakan invasif, termasuk operasi yang dilakukan pada pasien yang salah, pada sisi yang salah, atau menggunakan prosedur yang salah (secara tidak sengaja);
 - j) Tertinggalnya benda asing dalam tubuh pasien secara tidak sengaja setelah suatu tindakan invasif, termasuk operasi;
 - k) Hiperbilirubinemia neonatal berat (bilirubin >30 mg/dL);
 - l) Fluoroskopi berkepanjangan dengan dosis kumulatif >1.500 rad pada satu medan tunggal atau pemberian radioterapi ke area tubuh yang salah atau pemberian radioterapi >25% melebihi dosis radioterapi yang direncanakan;
 - m) Kebakaran, lidah api, atau asap, uap panas, atau pijaran yang tidak diantisipasi selama satu episode perawatan pasien
 - n) Semua kematian ibu intrapartum (terkait dengan proses persalinan); atau
 - o) Morbiditas ibu derajat berat (terutama tidak berhubungan dengan perjalanan alamiah penyakit pasien atau kondisi lain yang mendasari) terjadi pada pasien dan menyebabkan cedera permanen atau cedera sementara derajat berat.

BAB III

PELAPORAN DAN GRADING KESELAMATAN PASIEN

3.1 Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien merupakan setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Berikut merupakan contoh insiden yang berisiko terjadi di Rumah sakit.



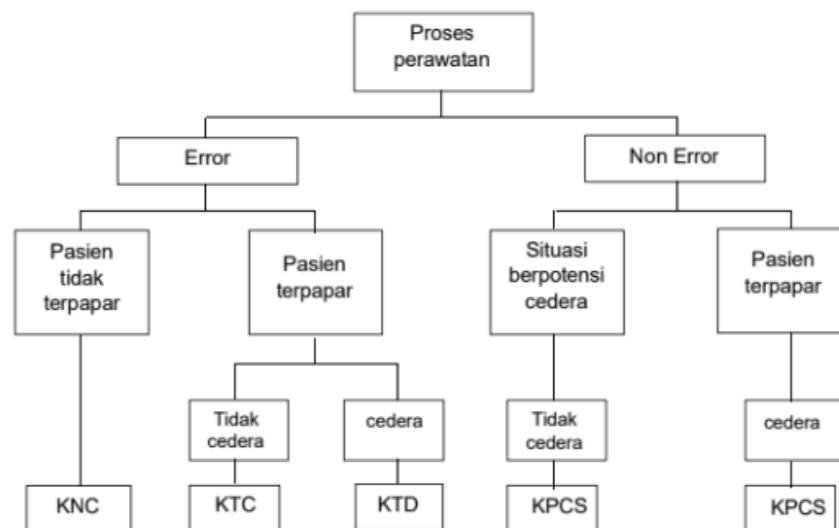
Bagan 3.1 Tipe Insiden di Rumah Sakit

Laporan insiden di Rumah sakit meliputi insiden yang terjadi pada pasien dan insiden yang terjadi pada keluarga pasien, pengunjung ataupun karyawan. Namun dalam pelaporannya masing-masing insiden berbeda. Komite mutu akan menindaklanjuti pelaporan insiden terkait pasien dan Komite K3 akan menindaklanjuti insiden terkait keluarga pasien, pengunjung, maupun karyawan. Pelaporan insiden keselamatan pasien sudah diatur dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017 sebagai berikut :

1. Setiap rumah sakit harus melakukan penanganan insiden untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
2. Penanganan insiden di rumah sakit dapat dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan penanganan insiden
3. Dalam melakukan penanganan insiden tim keselamatan pasien melakukan kegiatan berupa pelaporan, verifikasi, investigasi dan analisis insiden tanpa menyalahkan, menghukum dan mempermalukan seseorang.
4. Setiap insiden harus dilaporkan secara :
 - a. Internal
 - 1) kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam dengan menggunakan format laporan sebagai mana tercantum pada lampiran.
 - 2) Laporan akan diverifikasi oleh tim keselamatan pasien (unsur manajemen fasilitas pelayanan dan unsur klinis di fasilitas pelayanan)
 - 3) Tim keselamatan pasien melakukan investigasi dalam bentuk

- wawancara dan pemeriksaan dokumen
- 4) Tim keselamatan pasien menentukan derajat insiden (*grading*) dan melakukan *Root Cause Analysis* (RCA) dengan metode baku untuk menemukan akar masalah
- b. Eksternal
- 1) Kepada tim Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) sesuai dengan laporan pada formulir yang terlampir
 - 2) Insiden yang dilaporkan yakni : KTD dan sentinel
 - 3) Pelaporan insiden disampaikan setelah dilakukan analisis, serta mendapat rekomendasi dan solusi dari tim keselamatan pasien rumah sakit
 - 4) Setelah menerima pelaporan insiden KNKP akan melakukan pengkajian dan memberikan umpan balik (*feedback*) berupa rekomendasi untuk mencegah berulangnya kejadian yang sama di rumah sakit

3.2 Jenis Insiden di Rumah Sakit



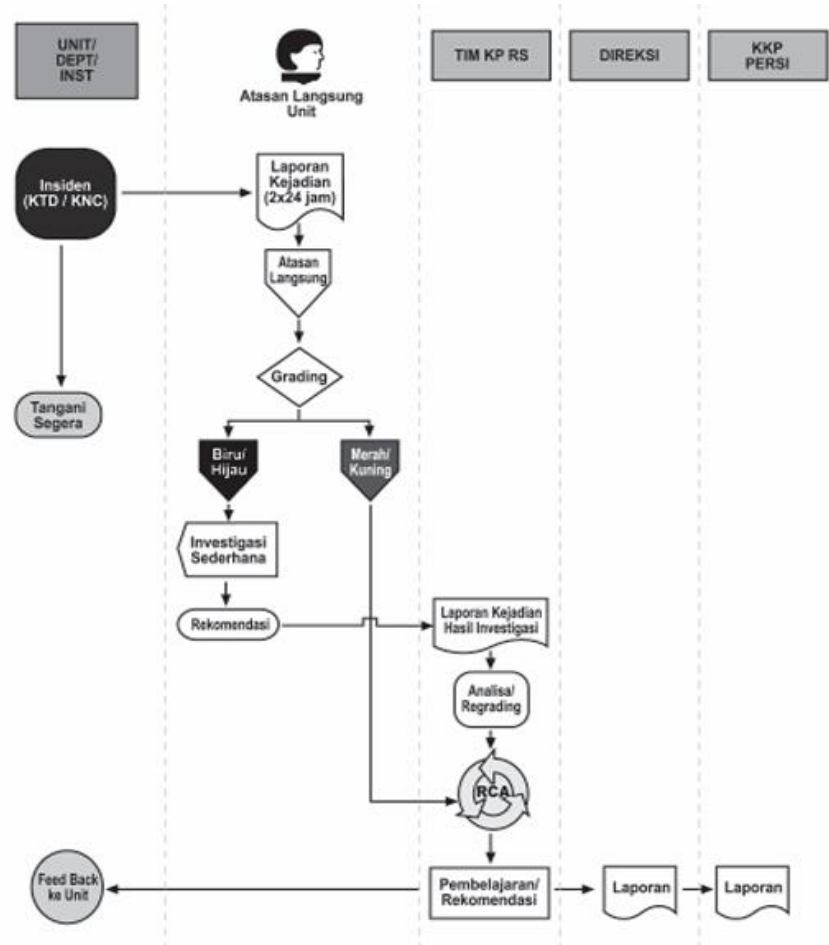
Bagan 3.2 Jenis Insiden di Rumah Sakit

Setiap Rumah sakit harus melakukan penanganan seluruh jenis insiden di rumah sakit, tidak terkecuali kejadian sentinel. Kejadian sentinel merupakan suatu Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien.

Kejadian sentinel yang berdampak luas / nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 (satu) jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan melalui media telepon kemudian dilengkapi dengan laporan tertulis. Laporan bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, paling sedikit memuat :

1. Lokasi kejadian
2. Kronologis kejadian
3. Waktu kejadian
4. Akibat kejadian
5. Jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel

3.3 Alur Pelaporan Insiden



Bagan 3.3 Alur Pelaporan Insiden

Penjelasan alur pelaporan insiden:

1. Apabila terjadi suatu insiden (KNC/KTD/KPC) di sekitar ruangan Rumah sakit, petugas wajib segera menindaklanjuti (di tangani) untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan.
2. Setelah menindaklanjuti, petugas yang mengetahui insiden tersebut segera membuat laporan insidennya dengan mengisi formulir insiden (terlampir) pada akhir kerja / shift kepada kepala ruangan (paling lambat 2 × 24 jam), diharapkan tidak menunda laporan.
3. Setelah mengisi form laporan, petugas segera menyerahkan kepada kepala ruang.
4. Kepala ruang memeriksa laporan insiden yang diberikan petugas, dan melakukan grading risiko terhadap insiden yang dilaporkan.
5. Hasil grading akan menentukan bentuk investigasi dan analisis yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Cara melakukan grading : melihat tabel probabilitas & tabel dampak sehingga kan ditemukan warna grading pada tabel derajat risiko.
 - (1) Dampak (Consequences)
 - a. Penilaian dampak / akibat suatu insiden adalah seberapa berat akibat yang dialami pasien mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal
 - (2) Probabilitas/Frekuensi/*Likelihood*
 - a. Penilaian tingkat probabilitas / frekuensi risiko adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi

Tabel 3.1 Penilaian Dampak Klinis/Konsekuensi/*Severity*

Tingkat Risiko	Deskripsi	Dampak
----------------	-----------	--------

1	Tidak signifikan	Tidak ada cedera
2	Minor	- Cedera ringan mis. luka lecet - Dapat diatasi dengan pertolongan pertama
3	Moderat	- Cedera sedang mis. luka robek - Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (<i>reversibeli</i>), tidak berhubungan dengan penyakit. - Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4	Mayor	- Cedera luas/berat misal cacat, lumpuh - Kehilangan fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (<i>irreversibel</i>), tidak berhubungan dengan penyakit
5	Katastropik	- Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

Tabel 3.2 Penilaian Probabilitas/Frekuensi

Tingkat Risiko	
1	Sangat jarang / <i>Rare</i> (>5 thn/kali)
2	Jarang / <i>Unlikely</i> (>2-5 thn/kali)
3	Mungkin / <i>Possible</i> (1-2 thn/kali)
4	Sering / <i>Likely</i> (Bebrp kali /thn)
5	Sangat sering / <i>Almost certain</i> (Tiap minggu /bulan)

Setelah nilai Dampak dan Probabilitas diketahui, dimasukkan dalam Tabel Matriks Grading Risiko untuk menghitung skor risiko dan mencari warna *bands* risiko.

- Skor Risiko

SKOR RISIKO = Dampak x Probabilitas

Cara menghitung skor risiko:

Untuk menentukan skor risiko digunakan matriks grading risiko (**tabel 6.**):

1. Tetapkan frekuensi pada kolom kiri,
2. Tetapkan dampak pada baris ke arah kanan,
3. Tetapkan warna *bands*nya, berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak.

b. Bands Risiko

Bands risiko adalah derajat risiko yang digambarkan dalam empat warna yaitu : Biru, Hijau, Kuning dan Merah. Warna "bands" akan menentukan Investigasi yang akan dilakukan :

- *Bands* BIRU : Investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktu maksimal 1 minggu
- *Bands* HIJAU : Investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktu maksimal 2 minggu Investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktu maksimal 2 minggu
- *Bands* KUNING : Investigasi komprehensif / analisis akar maslaah / RCA oleh Tim KPRS, waktu maksimal 45 hari
- *Bands* MERAH : Investigasi Komprehensif / analisis akar masalah / RCA oleh tim KPRS, waktu maksimal 45 hari

WARNA *Bands* : HASIL PERTEMUAN ANTARA NILAI DAMPAK YANG DIURUT KE BAWAH DAN NILAI PRIORITAS YANG DIURUT KE SAMPING KANAN

Contoh: Pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal, kejadian seperti ini di RS X terjadi pada 2 tahun yang lalu

Nilai dampak : 5 (katastropik) karena pasien meninggal

Nilai probabilitas : 3 (mungkin terjadi) karena pernah terjadi 2 thn lalu

Skoring risiko : $5 \times 3 = 15$ Warna Bands : Merah (ekstrim)

Tabel 3.3 Matriks Grading Risiko

Probabilitas	Tdk Signifikan 1	Minor 2	Moderat 3	Mayor 4	Katastropik 5
Sangat sering terjadi (Tiap minggu /bulan) 5	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi (beberapa kali/thn) 4	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi (1- ,2 thn/kali) 3	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Jarang terjadi (>2- ,5 thn/kali) 2	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang terjadi (>5 thn/kali) 1	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim

Tabel 3.4 Tindakan sesuai Tingkat dan *bands* risiko

Level / Bands	Tindakan
<i>Extreme</i> (sangat tinggi)	Risiko ekstrim, dilakukan RCA paling lama 45 hari membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke Direktur
<i>High</i> (tinggi)	Risiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 hari Kaji dengan detil & perlu tindakan segera serta membutuhkan perhatian top manajemen
<i>Moderate</i> (sedang)	Risiko sedang, dilakukan investig minggu. Manajer / Pimpinan KI terhadap biaya dan kelola risiko
<i>Low</i> (rendah)	Risiko rendah, dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin

- 6. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden akan dilaporkan kepada Tim Keselamatan Pasien Rumah sakit (KPRS)
- 7. Tim KPRS akan melakukan regrading melalui analisa kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan (komprehensif / RCA)

8. Setelah melakukan regrading, untuk hasil grading Kuning / Merah akan dilakukan Investigasi komprehensif / RCA oleh Tim KPRS
9. Setelah melakukan investigasi komprehensif / RCA, Tim KPRS akan membuat laporan dan rekomendasi untuk “perbaikan” serta “pembelajaran” berupa : petunjuk / *safety alert* untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali
10. Hasil rekomendasi dan rencana kerja dari investigasi komprehensif / RCA akan dilaporkan kepada Direksi
11. Rekomendasi untuk “perbaikan dan pembelajaran” diberikan kepada unit sebagai umpan balik dari pelaporan insiden. Unit terkait akan melakukan sosialisasi kepada seluruh sttaf di unit / unit lainnya
12. Tim KPRS akan melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil perbaikan yang dilakukan di unit
13. Untuk hasil investigasi dari insiden KTD / Sentinel akan dilakukan pelaporan ke KPPRS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit / Eksternal) melalui *e-reporting* dengan *website* resmi.

3.4 Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Formulir Laporan Insiden terdiri dari dua macam :

- a. Formulir Laporan Insiden (Internal)
Adalah formulir laporan yang dilaporkan ke Tim KP di Rumah sakit dalam waktu maksimal 2 x 24 jam. Laporan berisi : data pasien, rincian kejadian, tindakan yang dilakukan saat terjadi insiden, akibat insiden, pelapor dan penilaian grading (form terlampir)
- b. Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien (Eksternal)
Adalah formulir laporan yang dilaporkan ke KKP-RS setelah dilakukan analisis dan investigasi (form terlampir)

3.5 Petunjuk Pengisian Laporan IKP Eksternal

Login melalui link <https://mutufasyankes.kemkes.go.id/> dengan username dan password sesuai kode yang diberikan oleh KKPRS PERSI. Setelah login kita melakukan langkah-langkah dibawah ini:

A. Data Rumah Sakit

Pengisian data rumah sakit di isi sesuai dengan kondisi Rumah Sakit saat ini, yakni : Kepemilikan RS, Tipe RS, Kelas RS, Kapasitas Tempat Tidur, Propinsi (Lokasi RS). Setelah semua data Rumah Sakit dilengkapi masukan data insiden yang terjadi pada dasboar data pasien.

B. Data Pasien

Data Pasien : Umur pasien, Penanggung Biaya Pasien, Jenis Kelamin dan Tanggal mendapat pelayanan di isi dengan jelas sesuai dengan pelayanan yang diberikan saat di Rumah Sakit.

C. Rincian Kejadian

1. **Tanggal dan Waktu Insiden**, di isi tanggal dan waktu saat insiden (KTD/KNC) Terjadi. Buat prosedur pelaporan agar tanggal dan waktu insiden tidak lura. Insiden harus dilaporkan paling lambat 2x24 jam atau pada akhir jam kerja/shift.
2. **Insiden**, di isi insiden misalnya : pasien jatuh, salah identifikasi pasien, salah pemberian obat, salah dosis obat, salah bagian yang dioperasi, dll.
3. **Kronologi Insiden**, di isi ringkasanmulai saat sebelum kejadian sampai terjadinya insiden. Kronologis harus sesuai kejadian yang sebenarnya, bukan pendapat . asumsi pelapor.
4. **Jenis Insiden**, pilih salah satu insiden keselamatan pasien (IKP) : KTD/KNC/KPC/KTC/Sentinel.
5. **Orang pertama yang melaporkan insiden**, pilih salah satu pelapor yang paling pertama melaporkan terjadinya insiden. Misalnya petugas / keluarga pasien.

6. **Kejadian terjadi pada**, jika insiden terjadi pada pasien : laporkan ke KKP- RS. Jika insiden terjadi pada karyawan / keluarga pasien / pengunjung dilaporkan internal ke Tim K3RS.
7. **Insiden menyangkut pasien**, pilih salah satu : pasien rawat inap/ pasien rawat jalan/ pasien IGD / dll.
8. **Tempat / Lokasi**, tempat pasien berada. Missal ruang rawat inap, ruang rawat jalan, IGD, dll.
9. **Insiden sesuai kasus penyakit / spesialis**, pasien dirawat oleh spesialis ? (pilih salah satu). Bila kasus penyakit / spesialis lebih dari satu, pilih salah satu yang menyebabkan insiden. Misalnya : pasien gastritis kronis oleh internist, dikonsulkan ke bedah dengan suspect appendicitis. Saat appendectomy terjadi insiden tertinggal kasa, maka penanggung jawab kasus adalah : bedah. Bila dirawat oleh dokter umum : isi lain-lain : umum.
10. **Unit / Departemen yang menyebabkan insiden** , adalah unit / departemen yang menjadi penyebab terjadinya insiden misalnya : pasien DHF ke IGD, diperiksa laboratorium, ternyata hasilnya salah interpretasi.
 insiden : salah hasil lab pada pasien DHF
 Jenis insiden : KNC (tidak terjadi cedera)
 Tempat/Lokasi : IGD
 Spesialisasi : Kasus penyakit dalam
 Unit Penyebab : laboratorium
11. **Akibat insiden**, pilih salah satu (lihat tabel matriks grading risiko)
12. **Tindakan yang dilakukan segera setelah insiden**, ceritakan penanganan / tindakan yang saat itu dilakukan agar insiden yang sama tidak terulang lagi.
13. **Tindakan dilakukan oleh**, pilih salah satu : bila dilakukan tim sebutkan timnya terdiri dari siapa saja, missal : dokter, perawat.
 Jika dilakukan petugas lain : sebutkan missal analis, asisten apoteker, radiographer, bidan.
14. **Apakah insiden yang sama pernah terjadi di unit kerja lain ?**, jika ya, lanjutkan dengan mengisi pertanyaan dibawahnya : waktu kejadian di idi dalam bulan / tahun, tindakan yang telah dilakukan pada unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Jelaskan.

D. Tipe Insiden

Untuk mengisi Tipe insiden harus melakukan analisis dan investigasi terlebih dahulu. Insiden terdiri dari : Tipe Insiden dan Subtipe insiden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Tipe Insiden

No.	Tipe Insiden	Subtipe Insiden	
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. <i>Diagnosis/ assessment</i>

			3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart/</i> rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands/</i> kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang 4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan 7. Penyimpanan

			8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Ommited medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clothing</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Immunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresep 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa 10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresep/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply/</i> pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing/</i> alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait

		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. Supply/ order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah <i>rate/ flow/</i> konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi 7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a. Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangan tajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin

		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	Resource/ Manajemen organisasi	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan b. Ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan c. Sumber Daya Manusia d. Ketersediaan/ keadekuatan staf e. Organisasi/ Tim f. <i>Protocols/ Kebijakan/ SOP Guideline</i> g. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	a. Pengambilan/ <i>pick up</i> b. <i>transport</i> c. <i>sorting</i> d. data <i>entry</i> e. proses f. verifikasi/ validasi hasil	

- Contoh:
- Insiden : salah pemberian obat (IM menjadi IV)
Tipe insiden : medikasi
Subtipe insiden : proses pemberian medikasi: salah pemberian
Masalah: salah rute pemberian
 - Insiden : pasien jatuh dari tempat tidur
Tipe insiden : Jatuh
Subtipe insiden : tipe jatuh: slip/terpeleset
Keterlibatan saat jatuh: toilet
 - Insiden : tertukar hasil pemeriksaan laboratorium
Tipe insiden : laboratorium

Subtipe insiden : hasil

E. Analisis Penyebab Insiden Rekomendasi

- 1. Penyebab insiden dapat diketahui setelah melakukan investigasi dan analisa baik investigasi sederhana (*simple investigation*) maupun investigasi komprehensiv (*root cause analysis*).
- 2. Penyebab insiden terbagi dua yaitu :
 - a. Penyebab langsung (*immediate/direct cause*)
 - b. Penyebab yang langsung berhubungan dengan insiden / dampak terhadap pasien
 - c. Akar masalah (*root cause*).
- 3. Penyebab yang melatar belakangi penyebab langsung (*underlying cause*)
Penyebab insiden dapat digolongkan berdasarkan penggolongan faktor Kontributor seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Faktor kontributor dapat dipilih lebih dari satu.

Tabel 3.6 Faktor Kontributor, Komponen, dan Sub Komponen

1. FAKTOR KONTRIBUTOR EKSTERNAL / DI LUAR RS	
komponen	
a.	Regulator dan ekonomi
b.	peraturan & kebijakan depkes
c.	paraturna nasiobal
d.	hubungan dengan organisasi lain

2.FAKTOR KONTRIBUTOR ORGANISASI & MANAJEMEN	
Komponen	Sub komponen
Organisasi & manajemen	a. Struktur organisasi b. Pengawasan c. Jenjang pengambilan keputusan
Kebijakan, standar & tujuan	a. Tujuan & misi b. Penyusunan fungsi manajemen c. Kontak servis d. Sumber keuangan e. Pelayanan informasi f. Kebijakan diklat g. Prosedur & kebijakan h. Fasilitas & perlengkapan i. Manajemen risiko j. Manajemen K3 k. <i>Quality improvement</i>
Administrasi	Sistem adminitrasi
Budaya keselamatan	a. <i>Attitude</i> kerja b. Dukungan manajemen oleh seluruh staf
SDM	a. Ketersediaan b. Tingkat Pendidikan & Keterampilan Staf yang berbeda c. Beban kerja yang optimal
Diklat	Manajemen training pelatihan/refreshing

3.FAKTOR LINGKUNGAN KERJA	
Komponen	Sub komponen
Desain dan Bangun	a. Manajemen Pemeliharaan b. Penilaian Ergonomik Fungsionalitas
Lingkungan	a. Housekeeping b. Pengawasan Lingkungan Fisik Perpindahan Pasien antar Ruang
Peralatan/Sarana/Prasarana	a. Malfungsi alat

	b. Ketidaktersediaan c. Manajemen Pemeliharaan d. Fungsionalitas e. Desain, Penggunaan & Maintenance Peralatan
--	---

4. FAKTOR KONTRIBUTOR : TIM	
komponen	Sub komponen
Supervisi	a. Adanya kemaunan staf junior berkomunikasi b. Cepat tanggap
Konsistensi	a. Kesamaan tugas antar profesi b. Kesamaan tugas antar staf yang setingkat
Kepemimpinan & tanggung jawab	a. Kepemimpinan efektif b. Job desk jelas
Respon terhadap insiden	Dukungan peers setelah insiden

5. FAKTOR KONTRIBUTOR : PETUGAS	
komponen	Sub komponen
Kompetensi	a. Verifikasi kualifikasi b. Verifikasi pengetahuan & keterampilan
Stressor fisik dan mental	a. Motivasi b. Stressor mental : efek beban kerja= beban mental c. Stressor fisik : efek beban kerja = gangguan fisik

6. FAKTOR KONTRIBUTOR : TUGAS	
komponen	Sub komponen
Ketersediaan SOP	a. Proses peninjauan & revisi SOP b. Ketersedian SOP c. Kualitas Informasi d. Prosedur Investigasi
Ketersediaan & akurasi hasil test	a. Test tidak dilakukan b. Ketidaksesuaian antara interpretasi hasil test
Faktor penunjang dalam validasi alat	a. Ketersediaan, penggunaan, reliabilitas b. kalibrasi
Desain tugas	Penyelesaian tugas tepat waktu dan sesuai DOP

7. FAKTOR KONTRIBUTOR : PASIEN	
komponen	Sub komponen
Kondisi	Penyakit yang kompleks, berat, multikomplikasi
Personal	a. Kepribadian b. Bahasa c. Kondisi social d. keluarga
Pengobatan	Mengetahui resiko yangb berhubungan dengan pengobatan

Riwayat	a. riwayat medis b. riwayat keprobadian c. riwayat emosi
Hubungan staf dan pasien	Hubungan yang baik

8. FAKTOR KONTRIBUTOR ORGANISASI & MANAJEMNE	
komponen	Sub komponen
Komunikasi verbal	a. Komunikasi antar staf junior dan senior b. Komunikasi antar profesi c. Komunikasi antar staf dan pasien d. Komunikasi antar unit departemen
Komunikasi tertulis	Ketidaklengkapan informasi

- Contoh:
- Kesalahan identifikasi pasien sebelum pemberian obat
- Penyebab langsung (*Direct / Proximate/ Immediate Cause*)
 - Petugas: Perawat tidak melakukan identifikasi pasien menggunakan dua identitas sebelum pemberian obat.
 - Metode: Proses identifikasi pasien dilakukan hanya dengan menyebut nama panggilan pasien.
 - Lingkungan kerja: Ruangan pelayanan sedang sibuk sehingga petugas terburu-buru dalam memberikan obat.
 - Akar penyebab masalah (*underlying - root cause*)
 - Manajemen: Monitoring kepatuhan identifikasi pasien belum dilakukan secara konsisten.
 - SDM: Pemahaman petugas terhadap pentingnya identifikasi pasien belum optimal.
 - Metode: Sosialisasi dan evaluasi implementasi kebijakan identifikasi pasien belum berjalan efektif.
 - Rekomendasi / Solusi Bisa dibagi atas :
 - Jangka pendek:
 - Melakukan edukasi ulang kepada petugas yang terlibat mengenai prosedur identifikasi pasien.
 - Mengingatkan seluruh staf untuk melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien sebelum pemberian obat.
 - Melakukan supervisi langsung pada unit terkait.
 - Jangka menengah:
 - Melaksanakan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala.
 - Menyelenggarakan refresh training keselamatan pasien dan sasaran keselamatan pasien.
 - Menyediakan media pengingat (poster, stiker, banner) mengenai prosedur identifikasi pasien.
 - Jangka Panjang:
 - Mengintegrasikan sistem identifikasi pasien dengan teknologi barcode atau SIMRS.
 - Menjadikan kepatuhan identifikasi pasien sebagai indikator mutu unit.
 - Mengembangkan budaya keselamatan pasien melalui program pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan.

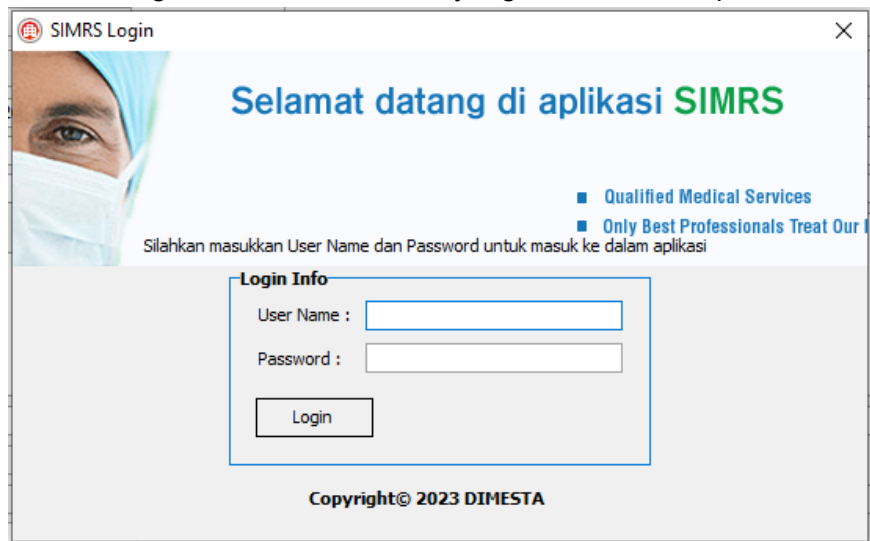
3.6 Manajemen Data SIMRS Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

3.6.1 Pelaporan IKP Internal melalui SIMRS

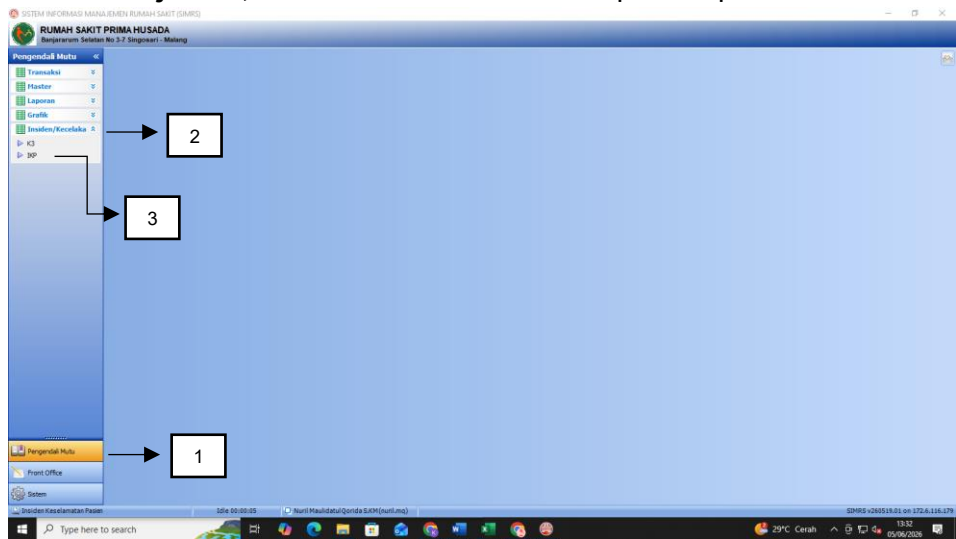
Selain mengumpulkan form pelaporan IKP kepala ruangan juga wajib

melakukan pelaporan IKP melalui billing SIMRS Rumah sakit berikut langkah - langkah pelaporan IKP melalui SIMRS Rumah sakit.

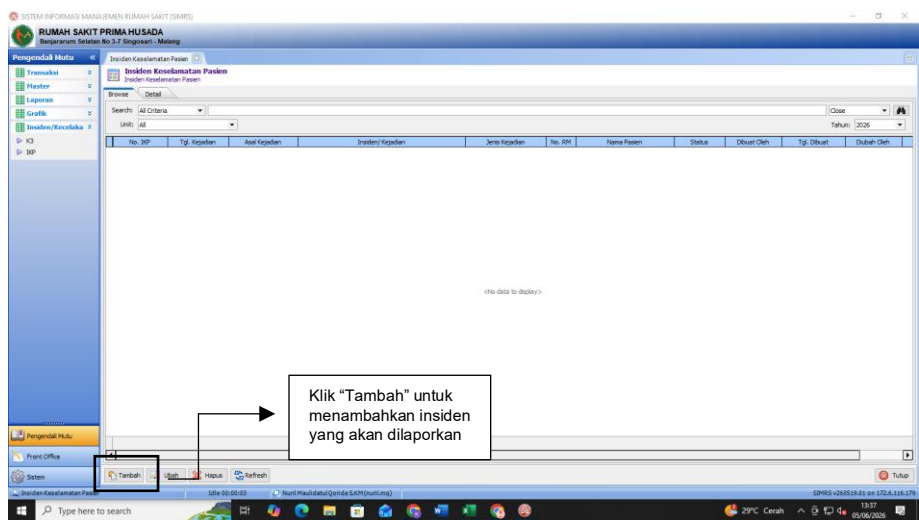
1. Lakukan **login ke SIMRS** dengan menggunakan user name & password sesuai dengan akun SIMRS Mutu yang dimiliki oleh kepala unit.



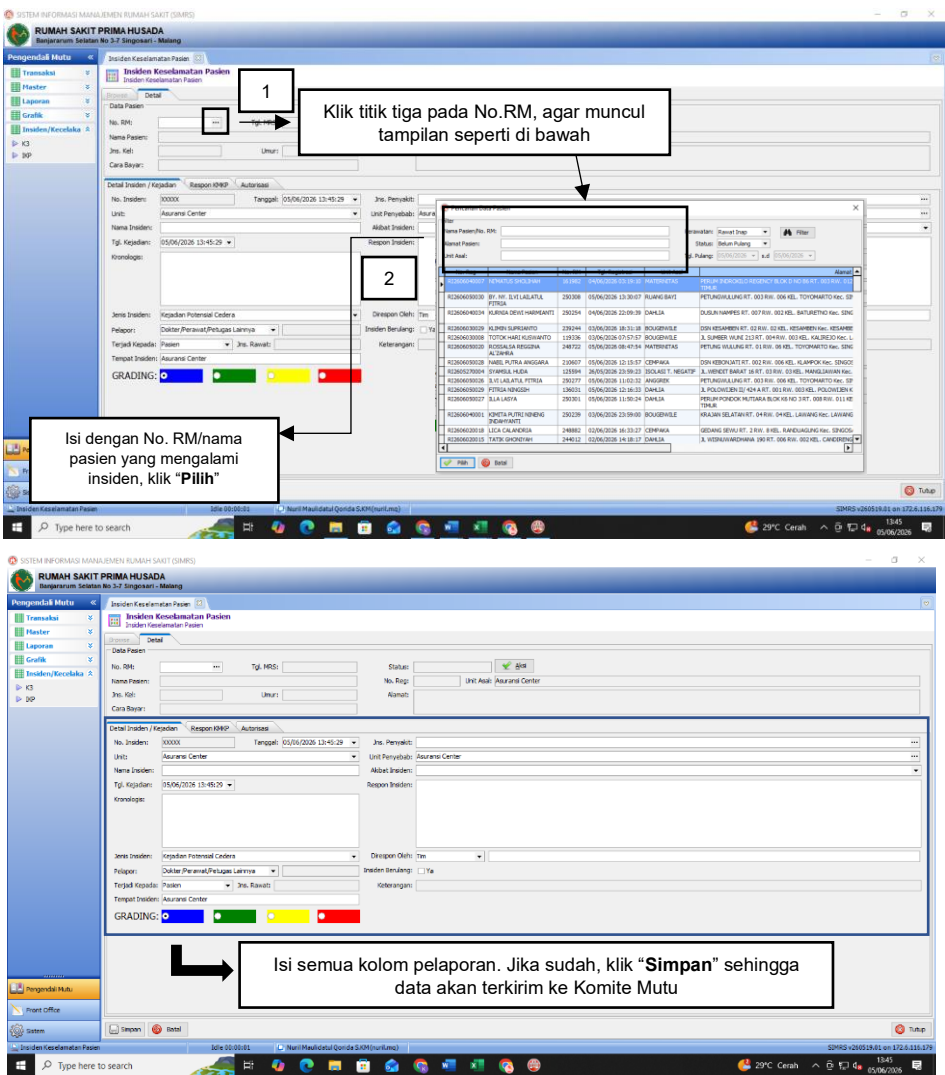
2. Setelah berhasil login pada menu **Pengendali Mutu**, klik pada menu **Insiden/Kejadian**, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini.



3. Selanjutnya, klik “Tambah” dan akan muncul form pelaporan dalam SIMRS berisi nama pasien, nomor RM, jenis insiden, sampai dengan grading insiden.



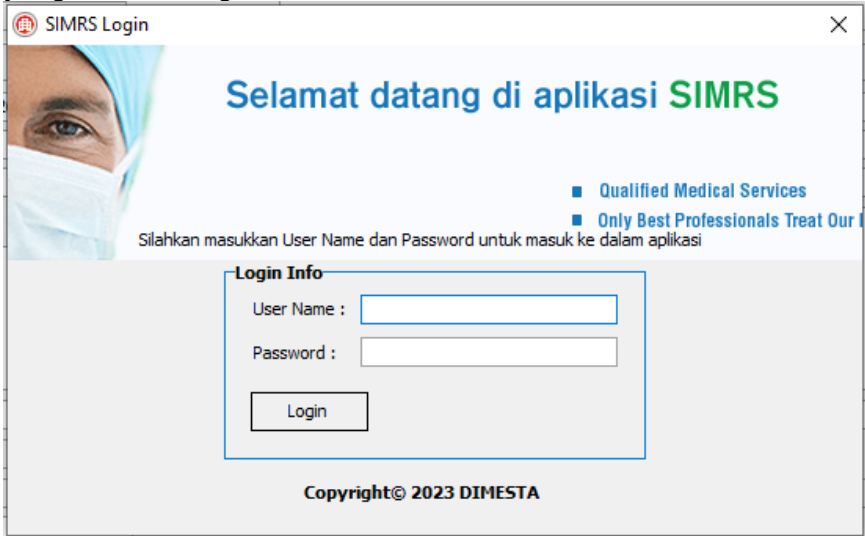
4. Setelah melampirkan nomor RM, seluruh data pasien seperti tanggal MRS, nama pasien, umur, dll akan otomatis terisi. Selanjutnya, lakukan penginputan detail insiden sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



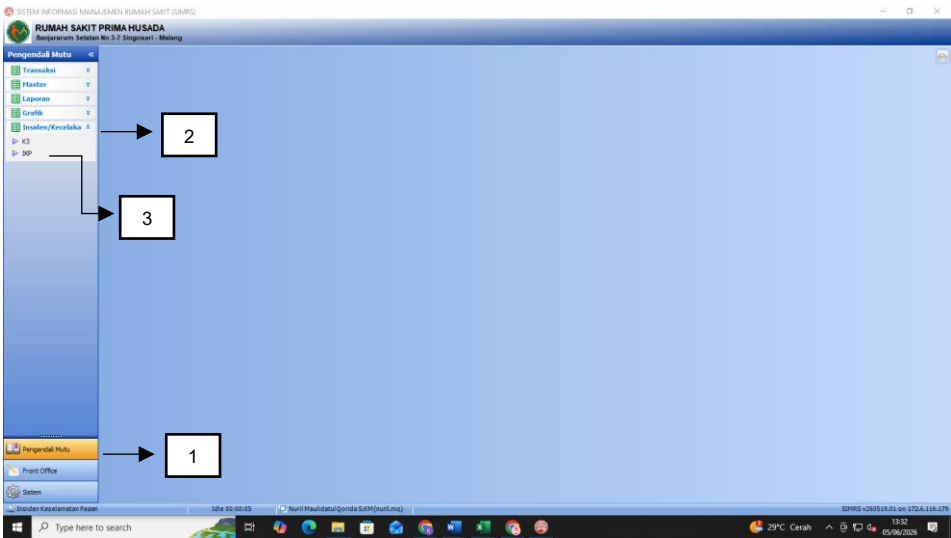
3.6.2 Respon Komite Mutu – Pelaporan IKP oleh Unit di SIMRS

Setelah unit melakukan pelaporan dalam waktu 2x24 jam dan mengkonfirmasi bahwa sudah melaporkan pada billing SIMRS, komite Mutu akan melakukan pengecekan pada SIMRS untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

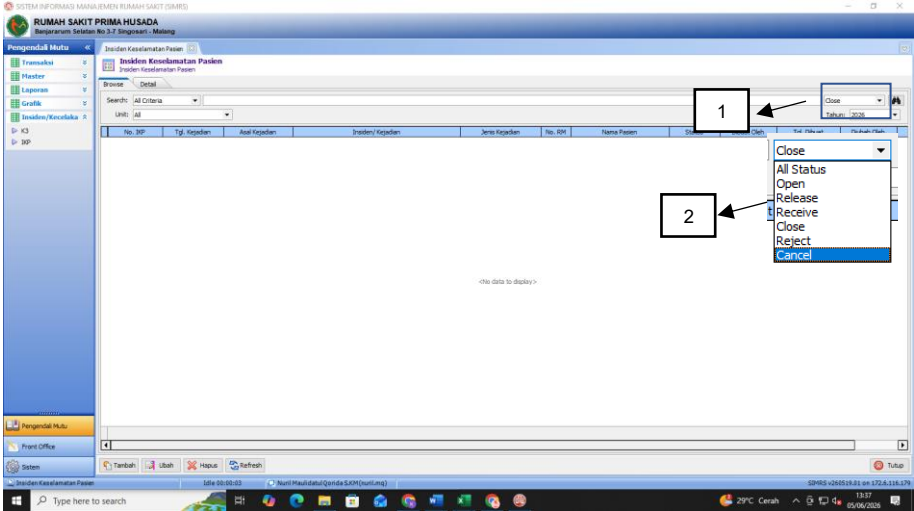
1. Lakukan login ke akun SIMRS dengan menggunakan username dan password yang sesuai dengan akun SIMRS.



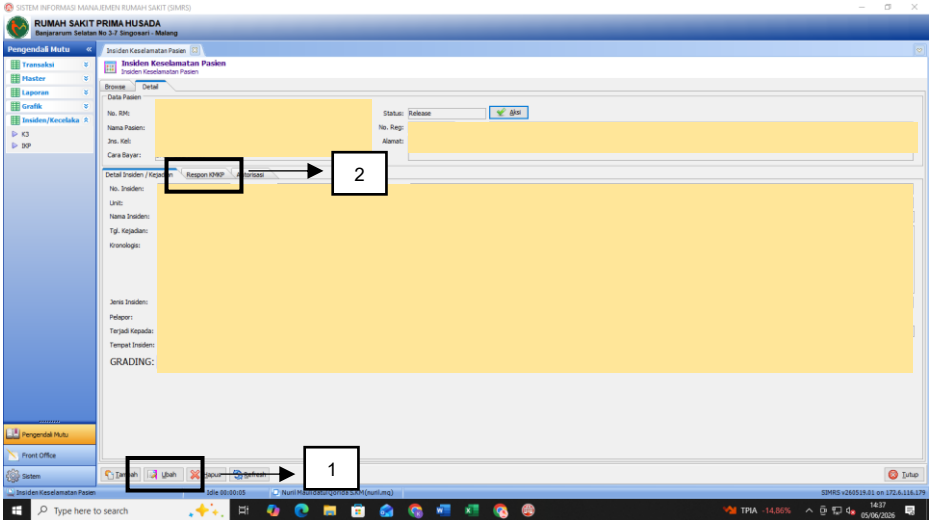
2. Setelah berhasil login pada menu **Pengendali Mutu**, klik pada menu **Insiden/Kejadian**, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini.



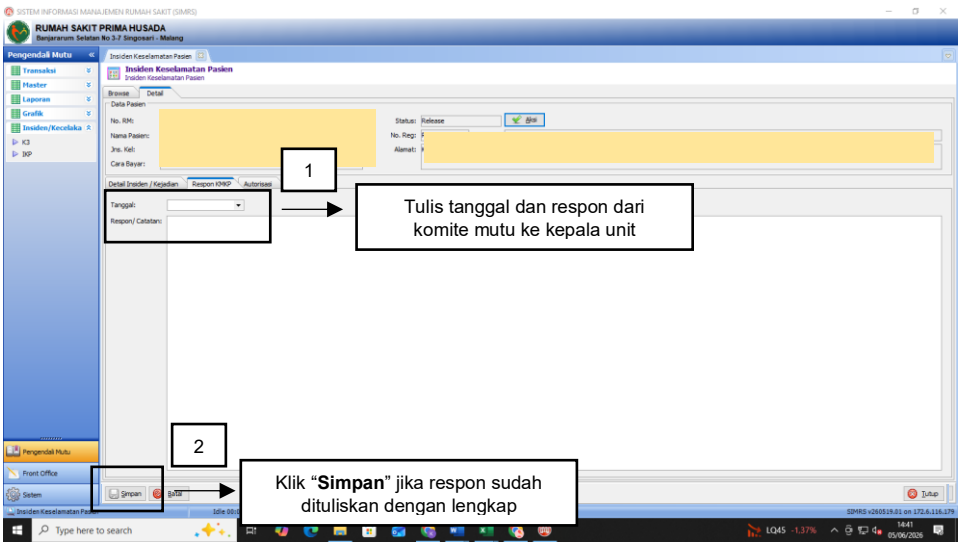
3. Pilih “all criteria” dan “release” untuk melihat insiden yang sudah dilaporkan oleh unit.



4. Klik “Ubah” untuk melihat deskripsi insiden dan menanggapi pelaporan dari unit. Lakukan *regrading* pada hasil pelaporan menggunakan kolom “Respon KMKP”



5. Tulis tanggal dan respon Komite Mutu terhadap insiden. Klik **Simpan** jika semua komentar sudah di tuliskan pada kolom **Respon KMKP**. Segera *follow up* kepada kepala ruangan untuk melaksanakan respon dari komite mutu.



BAB IV

PENANGANAN KEJADIAN SENTINEL YANG BERDAMPAK LUAS/NASIONAL

4.1 Definisi Kejadian Sentinel Yang Berdampak Luas/Nasional

Kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional meliputi kejadian sentinel yang memiliki potensi berdampak luas dan/atau kejadian sentinel yang melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lain. Kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ketentuan melaporkan dikecualikan untuk kejadian sentinel yang disebabkan oleh hal lain selain Insiden.

4.2 Pelaporan Kejadian Sentinel Yang Berdampak Luas/Nasional

- a. Kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 (satu) jam setelah diketahuinya kejadian sentinel.
- b. Pelaporan dilakukan secara lisan melalui media telepon kemudian dilengkapi dengan laporan tertulis.
- c. Pelaporan bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- d. Pelaporan paling sedikit memuat:
 - 1) lokasi kejadian;
 - 2) kronologis kejadian;
 - 3) waktu kejadian;
 - 4) akibat kejadian; dan
 - 5) jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel.

4.3 Tindak Lanjut Kejadian Sentinel Yang Berdampak Luas/Nasional

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menindaklanjuti laporan melalui kegiatan:
 - 1) Mencegah kejadian sentinel tidak meluas
Dilakukan paling sedikit berupa kegiatan membatasi/melokalisir dan mengurangi dampak kejadian sentinel
 - 2) Menyelamatkan barang bukti
Tindakan mengidentifikasi, memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti, serta membuat berita acara.
 - 3) Mengendalikan situasi
Mengamankan lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media massa, dan menenangkan pasien, keluarga pengunjung, dan tenaga kesehatan.
 - 4) Berkoordinasi dengan KNKP dan/atau instansi terkait.
- b. Direktur Jenderal menindaklanjuti laporan dengan menetapkan tim investigasi untuk melakukan investigasi.
 - 1) Tim investigasi terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, KNKP, organisasi profesi, tenaga pengawas, dan instansi lain terkait.
 - 2) Tim investigasi dalam melakukan penanganan kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional wajib berkoordinasi dengan Sub Komite Keselamatan Pasien RS Prima Husada dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten Malang.
 - 3) Tim investigasi bertugas mengumpulkan informasi dan barang bukti, menganalisis penyebab, solusi pencegahan perluasan dan/atau pengulangan kejadian sentinel yang berdampak luas/nasional, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim investigasi memiliki fungsi:
 - a) mendalami informasi dengan melakukan wawancara kepada semua pihak yang terlibat atau yang mengetahui kejadian;
 - b) mengamankan barang bukti;
 - c) mendata korban;

-
- d) mendokumentasikan hasil investigasi dalam bentuk dokumen, gambar, atau foto;
 - e) melakukan uji laboratorium;
 - f) membuat analisis dari seluruh informasi dan temuan, menyimpulkan penyebabnya serta merekomendasikan solusi pencegahan perluasan dan/atau pengulangan kejadian; dan/atau
 - g) menyusun laporan.
- 5) Fungsi pada poin a, b, dan c diperoleh dari:
- a) Pengkajian KNKP;
 - b) Direktur RS;
 - c) Tenaga kesehatan yang terlibat atau mengetahui kejadian;
 - d) Pasien/keluarga penerima layanan kesehatan;
 - e) Fasilitas pelayanan kesehatan lain atau institusi lain yang berhubungan secara langsung dengan kejadian;
 - f) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur/Kabupaten Malang, dan/atau
 - g) Sumber lainnya yang berhubungan secara langsung dengan kejadian.
- 6) Dalam rangka mengamankan dan menjaga keutuhan barang bukti, tim investigasi dapat memindahkan barang bukti dengan membuat berita acara.
- 7) Hasil kerja tim investigasi dibuat dalam bentuk laporan hasil investigasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal.
- 8) Laporan hasil investigasi terdiri atas:
- a) Laporan awal
Memuat paling sedikit berupa kesimpulan awal tentang kejadian sentinel dan rekomendasi pencegahan perluasan kejadian sentinel dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak kejadian sentinel dilaporkan.
 - b) Laporan akhir
disampaikan ketua tim investigasi kepada Direktur Jenderal paling lama 4 (empat) bulan setelah laporan awal disampaikan. Dalam kondisi tertentu, waktu laporan akhir investigasi dapat diperpanjang dengan cara melakukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal. Laporan akhir memuat:
 - (1) informasi fakta;
 - (2) analisis fakta penyebab kejadian sentinel;
 - (3) kesimpulan penyebab yang paling memungkinkan terjadinya kejadian sentinel;
 - (4) saran tindak lanjut untuk pencegahan pengulangan dan perbaikan; dan
 - (5) lampiran hasil investigasi pendukung lainnya.
- 9) Kejadian sentinel yang mengandung dugaan tindak pidana harus dilaporkan tim investigasi kepada Direktur Jenderal dengan rekomendasi untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 10) Barang bukti kejadian sentinel yang mengandung dugaan tindak pidana harus diserahkan tim investigasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB V

PENUTUP

Panduan Sistem Pelaporan dan Analisis Insiden Keselamatan Pasien ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh staf rumah sakit dalam melaksanakan pelaporan, investigasi, analisis, tindak lanjut, dan pembelajaran dari setiap insiden keselamatan pasien secara sistematis dan terstandar.

Penerapan panduan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya budaya keselamatan pasien yang kuat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh staf dalam pelaporan insiden, serta mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap mutu pelayanan kesehatan. Setiap insiden yang terjadi hendaknya dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki sistem, bukan untuk mencari kesalahan individu.

Panduan ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, standar akreditasi, serta kebutuhan rumah sakit guna mendukung terwujudnya pelayanan yang aman, bermutu, dan berfokus pada keselamatan pasien.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 03 Januari 2026

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M.Kes

Formulir 1

FORMULIR LAPORAN INSIDEN KE TIM KESELAMATAN PASIEN
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Nama Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAKSIMAL 2 x 24 JAM

A. DATA PASIEN

Nama :
No MR : Ruangan:
Umur : Bulan Tahun
Keompok Umus* : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan - 1 tahun
 ☐ > 1 tahun - 5 tahun ☐ > 5 tahun - 15 tahun
 ☐ > 15 tahun - 30 tahun ☐ > 30 tahun - 65 tahun
 ☐ > 65 tahun

Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Penanggung
biaya pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
 ☐ Pemerintah ☐ Perusahaan*
 ☐ BPJS ☐ Lain-lain

Tanggal Masuk
Rumah Sakit/
Fasyankes lain : Jam :

B. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden
 Tanggal : Jam

2. Insiden :

3. Kronologis Insiden

4. Jenis Insiden* :
 ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
 ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event) / Kejadian Sentinel (*Sentinel Event*)

-
- ☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
- ☐ KPC
5. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
- ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
- ☐ Pasien
- ☐ Keluarga / Pendamping pasien
- ☐ Pengunjung
- ☐ Lain-lain (sebutkan)
6. Insiden terjadi pada* :
- ☐ Pasien
- ☐ Lain-lain
(sebutkan)
- Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke
K3 RS/unit K3 Fasyankes lain
7. Insiden menyangkut pasien :
- ☐ Pasien rawat inap ☐ Pasien rawat jalan
- ☐ Pasien UGD
- ☐ Lain-lain
(sebutkan)
8. Tempat Insiden
- Lokasi kejadian (sebutkan)
(Tempat pasien berada)
9. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
- ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
- ☐ Anak dan Subspesialisasinya
- ☐ Bedah dan Subspesialisasinya
- ☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
- ☐ THT dan Subspesialisasinya
- ☐ Mata dan Subspesialisasinya
- ☐ Saraf dan Subspesialisasinya
- ☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
- ☐ Kulit dan Kelamin dan Subspesialisasinya
- ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
- ☐ Paru dan Subspesialisasinya
- ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
- ☐ Lain-lain (sebutkan)
10. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
- Unit kerja penyebab (sebutkan)
11. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
- ☐ Kematian

- ☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
- ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
- ☐ Cedera Ringan
- ☐ Tidak ada cedera

12. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
.....
.....
.....

13. Tindakan dilakukan oleh* :
☐ Tim : terdiri dari :
☐ Dokter
☐ Perawat
☐ Petugas lainnya

14. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*

☐ Ya ☐ Tidak

Apabila ya, isi bagian dibawah ini.

Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....
.....

Pembuat Laporan	:	Penerima Laporan	:
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Terima	:	Tgl Lapor	:

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

BIRU HIJAU KUNING MERAH

NB. * = pilih satu jawaban.

Formulir 2

Form data Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain untuk pelaporan insiden ke Komite Nasional Keselamatan Pasien melalui Pos

Silahkan Isi User name Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
UNTUK MELAPORKAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN KE KOMITE
NASIONAL KESELAMATAN PASIEN

User name Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain:_____

Bagi Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang belum mengetahui user name rumah sakit, silahkan melakukan registrasi isi Formulir Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibawah ini, yang dapat diakses lewat :
<http://www.buk.depkes.go.id>

Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien ke KNKP Melalui Pos

RAHASIA

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN
LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN KNKP
(Patient Safety Incident Report)

Nomor

- Laporan ini hanya dibuat jika timbul kejadian yang menyangkut pasien. Laporan bersifat anonim, tidak mencantumkan nama, hanya diperlukan rincian kejadian, analisa penyebab dan rekomendasi.
- Untuk mengisi laporan ini sebaiknya dibaca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), bila ada kerancuan persepsi, isilah sesuai dengan pemahaman yang ada.
- Isilah semua data pada Laporan Insiden Keselamatan Pasien dengan lengkap. Jangan dikosongkan agar data dapat dianalisa.
- Segera kirimkan laporan ini langsung ke Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP)

KODE RS/Fasyankes Lain : (lewat : ttp://www.buk.depkes.go.id)

A. DATA PASIEN

Umur	:	 Bulan	 Tahun
Kelompok umur	:	☐ 0-1 bulan	☐ > 1 bulan - 1 tahun
		☐ > 1 tahun - 5 tahun	☐ > 5 tahun - 15 tahun
		☐ > 15 tahun - 30 tahun	☐ > 30 tahun - 65 tahun
		☐ > 65 tahun	
Jenis kelamin	:	☐ Laki-laki	☐ Perempuan
Penanggung biaya pasien	:	☐ Pribadi	☐ Asuransi Swasta
		☐ Pemerintah	☐ Perusahaan*
		☐ BPJS	☐ Lain-lain

Tanggal Masuk

RS/Fasyankes Lain : Jam

B. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

Tanggal : Jam

2. Insiden :

3. Kronologis Insiden

.....
.....
.....

4. Jenis Insiden* :

- ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (*Near miss*)
☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (*Adverse Event*) / Kejadian Sentinel (*Sentinel Event*)
☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC

5. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*

- ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
☐ Pasien
☐ Keluarga / Pendamping pasien
☐ Pengunjung
☐ Lain-lain (sebutkan)

6. Insiden terjadi pada* :

- ☐ Pasien
☐ Lain-lain (sebutkan)

Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3 RS/Unit K3 Fasyankes Lain.

7. Insiden menyangkut pasien :

- ☐ Pasien rawat inap D Pasien rawat jalan D Pasien UGD
☐ Lain-lain (sebutkan)

8. Tempat Insiden

Lokasi kejadian (sebutkan)
(Tempat pasien berada)

9. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)

- ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
☐ Anak dan Subspesialisasinya
☐ Bedah dan Subspesialisasinya
☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
☐ THT dan Subspesialisasinya

D. ANALISA PENYEBAB INSIDEN

Dalam pengisian penyebab langsung atau akar penyebab masalah dapat menggunakan Faktor kontributor (bisa pilih lebih dari 1)

- a. Faktor Eksternal / di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Faktor Organisasi dan Manajemen
- c. Faktor Lingkungan kerja
- d. Faktor Tim
- e. Faktor Petugas / Staf
- f. Faktor Tugas
- g. Faktor Pasien
- h. Faktor Komunikasi

1. Penyebab langsung (*Direct / Proximate/ Immediate Cause*)

.....

.....

.....

.....

2. Akar penyebab masalah (*underlying - root cause*)

.....

.....

.....

.....

3. Rekomendasi / Solusi

No	Akar Masalah	Rekomendasi/Solusi

NB. * : pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain.

Saran : baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Formulir 3

Laporan Insiden Eksternal
(Panduan e- report bagi Rumah Sakit dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lain)

- Akses Website KKPRS yaitu : <http://www.buk.depkes.go.id>
- Klik Banner Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di sebelah kanan atas.
- Setelah tampil terdapat 2 isian yang perlu diperhatikan yaitu :
 - ✚ Bagi Rumah Sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang **telah mempunyai kode rumah sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan lain** untuk melanjutkan ke form laporan Insiden keselamatan pasien KNKP
 - ✚ Bagi Rumah sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang **belum mempunyai kode rumah sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan lain** diharapkan mengisi Form data isian RS untuk mendapatkan **kode rumah sakit** yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke form Laporan Insiden, KNKP.
- Apabila masih kurang jelas silahkan hubungi :

SEKRETARIAT KNKP

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
d/a Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon / fax : (021) 5274915

Surat elektronik : subdit.rspendidikan@gmail.com